

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	淋巴瘤 Lymphoma				
編號	A31000-Q03-W-K11	制定者	N17 陳瑩婕	公布日期	99 年 01 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.7 版/13 頁	審查者	曾翊婕	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員能瞭解淋巴瘤的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，增加臨床照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

淋巴瘤是指淋巴細胞（又稱淋巴球，為白血球的其中 1 類，負責免疫系統中許多複雜的功能）在不同的發育階段過程中出現病變而造成血液細胞瘤，俗稱淋巴瘤。依據病理型態學的不同以及臨床表現的差異，通常可分為何杰金氏淋巴瘤(Hodgkin's disease)以及非何杰金氏淋巴瘤(non-Hodgkin's lymphoma；NHL)。若依細胞來源不同又可將淋巴瘤分為 B 細胞淋巴瘤或 T 細胞淋巴瘤，B 細胞非何杰金氏淋巴瘤的發生率較高，且頭頸部淋巴瘤大多由 B 淋巴細胞而來。何杰金氏淋巴瘤好發於 20-40 歲和 55 歲以上的人，男性居多，發生率低，發病年齡較早，治療預後較好，5 年存活率可達 90%，10 年存活率達 80%；非何杰金氏淋巴瘤好發於 55 歲以上的人，男性居多，發生率高，佔所有淋巴瘤的 90%，發病年齡較晚，治療預後較差，東方人較多，目前排行在國內男性死亡率第九位的癌症。

（二）成因

非何杰金氏淋巴瘤沒有單一的成因，但有些因素會增加罹患的風險：

主題名稱	淋巴瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/13

1. 日漸衰老的男士。

2. 因為以下情況而使免疫系統減弱。

(1) 接受器官移植手術後服用抑制免疫能力的藥物。

(2) HIV／AIDS。

(3) 自體免疫疾病，如：類風濕性關節炎或乾躁症（又稱修格連氏症候群）。

(4) 遺傳性失調，如：毛細血管擴張性運動失調(ataxia-telangiectasia)。

(5) 感染，如：人體 T 細胞白血病/淋巴瘤病毒(HTLV-1)、伊波病毒(Epstein-Barr virus)、或幽門螺旋菌(Helicobacter pylori)。

(6) 暴露於農藥中。

(7) 曾經接受放射療法或化學療法。

（三）症狀

非何杰金氏淋巴瘤可區分為源發自淋巴腺的 NHL(nodal lymphoma)，以及淋巴腺以外的 NHL(extranodal lymphoma)。人體內淋巴腺以外的相關類淋巴系統組織遍布於腸胃道、扁桃腺、鼻咽、肺、肝、脾、甲狀腺、骨髓、皮膚等部位。NHL 常見之臨床表現，主要是出現局部性或全身表淺部位無痛性淋巴腺的腫大，肝脾腫大及腹部腫瘤塊的出現也常發生。而這些進行性的淋巴瘤會逐漸腫大，可能對鄰近的正常組織產生壓迫或造成阻塞。此外，NHL 也可能直接侵犯肺臟實質、肋膜、心包膜，造成咳嗽、呼吸急促、肋膜腔或心包膜腔的積水。如直接侵犯腸胃道，或發生腹膜腔後面腫大淋巴腺的壓迫，則可能造成腸胃潰瘍、穿孔、出血、阻塞或吸收不良等症狀。在肝膽系統方面，淋巴腺腫大後引起的膽道阻滯，或淋巴瘤直接經由血液循環造成的肝浸潤，都會引起黃疸。偶而淋巴瘤會自縱膈腔或腹膜腔的後部侵入脊椎管，壓迫脊髓或脊髓神經，造成神經學的徵候。若淋巴瘤直接侵犯脊髓液中或骨髓裡，則會造成全血球計數(CBC)、血液生化學、脊髓液生化學及細胞學的結果異常。其它臨床上也可能出現體重減輕、發燒、夜間盜汗等非特異性的症狀，這些非特異性症狀有時被稱為「B symptoms」(意指淋巴瘤特有的腫瘤症狀)。以下介紹淋巴瘤對不同器官組織所造成的影響：

主題名稱	淋巴瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/13

- 1.呼吸系統：如直接侵犯肺臟、肋膜、心包膜，則會造成咳嗽、呼吸困難、肋膜腔或心包膜腔之積水。
- 2.腸胃道系統：腸胃道受到侵犯或發生腹膜腔後腫大淋巴結壓迫，將可能造成腹脹、腹痛、胃腸潰瘍、穿孔、出血、吸收不良等症狀。
- 3.肝膽系統：腹腔內淋巴結腫大後會引起膽管阻塞造成膽汁無法排除，或因直接侵犯肝臟而引起黃疸。
- 4.鼻腔及鼻咽腔：可能會引起鼻塞、流鼻血等一些類似慢性鼻竇炎的症狀。
- 5.骨髓：造血功能變差，紅血球減少出現貧血而臉色蒼白；血小板減少會造成不正常出血，血液中含有不正常的淋巴球細胞。
- 6.神經系統：如淋巴瘤侵入脊椎管，壓迫脊髓或脊髓神經，會造成疼痛、感覺異常等神經系統症狀。
- 7.中樞神經系統：淋巴瘤如侵入腦膜或腦實質內，會造成顱內壓增高，引起頭痛、視力模糊或運動失調。

（四）常見檢查

如果懷疑是非何杰金氏淋巴瘤時，醫師會詢問個人病史，並且執行理學檢查，以確定診斷。檢查可能包括觸診頸部、腋下、腹股溝淋巴結或血液檢查。做全身的檢查，包括血液常規與生化檢查、X光、電腦斷層、核磁共振或是淋巴管攝影(Lymphangiogram)、正子攝影等，以檢查身體其它部位器官及淋巴組織是否有癌化細胞。若要更進一步確定是否為淋巴瘤時，仍須藉由淋巴結的病理組織切片才能確立診斷。由於淋巴瘤的病理分類非常多，且不同的分類及分化程度，其治療方式和預後是完全不一樣，所以病理組織切片是非常重要的。除了臨床上的症狀可以提供診斷參考外，醫師還會了解詳細的病史及做身體檢查，檢查的項目可能包括：

1. 血液常規檢查：抽血結果可能會呈現貧血，此是由疾病本身所造成，或是骨髓受侵犯所引起，有 1/3 的病人白血球會增加，特別是嗜伊紅性白血球，部份病人會有血小板減少情形，紅血球沈降速率也會升高。

主題名稱	淋巴瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/13

2. 血液生化檢查：包括肝、腎功能及電解質的檢查，淋巴瘤的增殖速度異常的快，常引起高尿酸血症，部份血清鹼性磷酸酶、乳酸去氫酶會升高。
3. 胸部 X 光：了解縱膈腔淋巴結或肺部是否受到侵犯。
4. 腹部超音波：可偵測肝、脾是否受到侵犯，如果看到懷疑的病變處，可做肝臟穿刺或切片檢查來確定。
5. 電腦斷層攝影及磁振造影：包含胸部、腹部及骨盆腔的斷層攝影來評估深部的淋巴結是否有被侵犯而腫大。
6. 骨髓穿刺切片檢查：以了解淋巴瘤是否侵犯至骨髓。
7. 淋巴攝影(Lymphangiogram)：淋巴攝影技術不易，且較易引起過敏反應，所以並不是所有的病人都須做此項檢查。
8. 剖腹探查術：常用在何杰金氏淋巴瘤，目的在於觀察胰臟是否受到侵襲。

(五) 淋巴瘤之分期

必須瞭解淋巴瘤的分期，才能針對不同的病情來做最適當的治療。包含淋巴結感染的數目、淋巴結感染的部位是否擴散至骨髓、脾或淋巴系統以外的器官，如肝臟。臨床上，淋巴瘤可分成四期：

1. stage I：有一處淋巴區域有淋巴瘤細胞侵犯。
2. stage II：橫膈之同一側有兩處以上的淋巴區域或一處淋巴結和一處淋巴結外器官有淋巴瘤細胞之侵犯。
3. stage III：橫膈兩側皆有淋巴瘤細胞侵犯時。
4. stage IV：淋巴瘤瀰漫性地侵犯各器官或淋巴結時，尤其是一旦侵犯到骨髓時，即屬第四期。

此外，每一期別可再區分為 A 或 B 期。若病人沒有不明原因超過 38°C 之高燒、夜間盜汗、及 6 個月內體重減輕 10% 以上之症狀則為 A 期，反之為 B 期。

(六) 常見治療

淋巴瘤的治療方式必須依照其細胞型態與臨床分期而訂出治療計劃。淋巴瘤的治療方式包括放射線治療、化學治療及復發使用高劑量化學治療合併自體或異體周

主題名稱	淋巴瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/13

邊血幹細胞移植。淋巴瘤治療的成效會因腫瘤侵犯位置、組織分類、腫瘤分期及治療方式有所影響，若能在低分期時被診斷出來，則有較好的預後與存活率。以下依不同惡性度及期別的淋巴瘤臨床治療方式：

1. 低惡性度淋巴瘤：又分為低期別及高期別來區分：

(1) 低期別（I 或 II 期）的淋巴瘤病人，採用放射線治療，約有 10~15%的病人在經過適當的放射線治療後得到緩解。

(2) 高期別（III 或 IV 期）的病人，病期長且無明顯的症狀，可先觀察，不必急於給予全身性化學治療，等病人出現明顯症狀再進行化學治療即可。

2. 中、高惡性度淋巴瘤

主要的方式為化學治療，因為其病程進展快速，如沒有給予正確、有效的治療，短期內可能會造成生命危險。如積極化學治療 70~85%的病人可達緩解，甚至有 25~45% 的病人可達痊癒。目前其複合式化學治療處方為 CHOP(Cyclophosphamide、Doxorubicin、Vincristine、Prednisolone)，通常每三個星期為一個療程，可能需要治療 6~8 個療程。

3. 何杰金氏淋巴瘤

何杰金氏淋巴瘤本身就較少侵犯淋巴結以外的器官，其治療效果也不錯。對於第 I 或 II 期病人可使用放射線治療，第 III 或 IV 期病人則需加上化學治療，MOPP(Nitrogen mustard、Vincristine、Procarbazine、Prednisolone)及 ABVD (Adrimycin、Bleomycin、Vinblastine、Dacarbazine)，每四星期為一週，約要 6~8 個療程。

4. 骨髓移植(Bone marrow transplantation；BMT)

針對復發的病人，骨髓或造血幹細胞移植常做為治療方法之一。先使用高劑量化學治療或放射線治療，盡可能摧毀體內殘留的淋巴瘤細胞，而再移植入已先存好的骨髓或造血幹細胞來避免造血系統的無法恢復。目前除了復發的病人，對初步診斷的非何杰金氏淋巴瘤病人，若同時具有多個不好的預後因素（易復發），則也可考慮於傳統化療療程結束時，再給於高劑量化療及移植，以減少復

主題名稱	淋巴瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/13

發之機率。

5. 免疫療法(immunotherapy)

在近年已漸漸成為癌症治療的主要療法之一，其原理乃直接或間接利用人體免疫系統內的免疫細胞及抗體來對抗癌症，或減少因癌症或其治療所引致之副作用。通常抗體常被設計來認識與對抗特殊的抗原，而其抗癌作用具有療效高且副作用低之特性。因 90% 的 B 淋巴細胞非何杰金氏淋巴瘤，其淋巴瘤細胞上會有 CD20 表面抗原，新近發展出之對抗 CD20 的單株抗體 Rituximab，便是利用其與 CD20 抗原結合，所引起的補體依賴性細胞毒殺作用(CDCC)及抗體依賴性細胞毒殺作用(ADCC)等免疫反應，來達到消滅淋巴瘤細胞的目地。

(七) 護理問題

1. 健康保護能力不足／與放射線治療有關。
2. 健康保護能力不足／與淋巴瘤需長期使用類固醇治療有關。
3. 易感染／與化學治療（放射線治療）有關。
4. 易感染／與免疫系統受抑且白血球下降（ $5000/\text{mm}^3$ 以下）有關。
5. 口腔黏膜異常／與淋巴瘤需長期使用類固醇治療有關。
6. 體液容積太多／與調節機轉失調（心、肝、肺、腎疾病）有關。
7. 疼痛不適／與淋巴瘤疾病本身有關。

(八) 護理措施：

1. 健康保護能力不足／與放射線治療有關
 - (1) 監測血液檢查值並觀察其變化（CBC/DC 的檢驗報告）。
 - (2) 注意觀察照射部位皮膚之變化。
 - (3) 避免刺激皮膚或按摩皮膚。
 - (4) 避免使用肥皂清潔皮膚。
 - (5) 勿隨意在治療部位擦潤滑劑及乳液。
 - (6) 若為頸部附近放射線治療，應加強口腔護理。
 - (7) 注意有無感染症狀發生。

主題名稱	淋巴瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/13

(8)盡量避免到公共場所，減少感染機會。

(9)若白血球下降至正常範圍，應提供適當隔離及保護措施。

(10)會診營養科，提供或教導攝取正確及足夠的營養以增加抵抗力。

2.健康保護能力不足／與淋巴瘤需長期使用類固醇治療有關

(1)評估大小便、胃液有無潛血反應。

(2)評估口腔牙齦有無不正常的出血現象。

(3)監測經血量。

(4)監測血液檢查值並觀察其變化（WBC、Hb、Ht、PT、PTT、BT__時間）。

(5)維持安全環境避免外傷，提醒病人注意安全，保護皮膚勿碰撞，避免出血。

(6)注意觀察有無感染症狀。

(7)教導病人注意出血的警訊。

(8)避免肌肉注射或盡量改由口服或靜脈給藥。

(9)避免使用肛門與陰道塞劑。

(10)囑咐病人勿擅自更改藥量，或驟然停止藥物。

(11)提供相關藥物的副作用、禁忌等注意事項之書面資料給病人參考。

(12)盡量避免到公共場所，減少感染機會。

(13)若白血球下降至正常範圍，應提供適當隔離及保護措施。

(14)告知病人或家屬打針、抽血後，按壓針孔部位 3-5 分鐘，且勿揉擦。

3.易感染／與化學治療（放射線治療）有關

(1)監測生命徵象。

(2)監測全血球計數(CBC)並報告 WBC 異常現象。

(3)監測藥物副作用並衛教藥物注意事項及可能之副作用。

(4)監測輸液注射部位有無感染情形並教導維持輸液的通暢性。

(5)治療前後洗手。

主題名稱	淋巴瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	8/13

(6)運用適當隔離技術，包括口罩、手套或隔離衣。

(7)避免侵入性治療，如有必要採無菌技術執行。

(8)依醫囑按時給予抗生素或抗癌藥物。

(9)教導感染的危險因子及預防感染的重要性方法。

(10)指導炎症症狀及徵象。

(11)教導選擇高蛋白、高維生素飲食及相關疾病飲食衛教。

4.易感染／與免疫系統受抑且白血球下降（ $5000/\text{mm}^3$ 以下）有關

(1)評估危險因子，如：年齡、營養狀況、用藥、衛生習慣及感染原等。

(2)教導病人與家屬訪客注意事項，如：在接近他之前先洗手。

(3)視需要限制訪客，減少病人的暴露及預防感染。

(4)安置於隔離病房。

(5)教導病人及家屬感染的危險因子包括年齡、營養不良、不衛生的生活狀況、化學治療及侵入性治療或藥物（抗生素、類固醇）等方面，及被感染的危險性。

(6)鼓勵和維持飲食中熱量及蛋白質的攝取，例如肉類、蛋類等，並注意飲食的清潔。

(7)教導病人及家屬感染的症狀與徵象，如（紅、腫、熱、痛、發燒）。

(8)教導病人及家屬感染的危險因子，包括年齡、營養不良、不衛生的生活狀況、化學治療及侵入性治療或藥物（抗生素、類固醇）等方面及被感染的危險性鼓勵和維持飲食中熱量及蛋白質的攝取，例如肉類、蛋類等，並注意飲食的清潔。

(9)盡量減少住院日數以預防院內感染。

(10)監測抗維生素治療的使用（應按醫囑在規定時間的十五分鐘內給藥，以確保維持適當的治療濃度，預防產生抗藥性）。

(11)對於暴露會威脅生命疾病（如水痘、肝炎）的病人，依醫囑給予免疫球蛋白。

主題名稱	淋巴瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	9/13

(12)嚴格限制只有在絕對必要時才使用侵入性治療或檢查，需採取無菌技術執行。

(13)在接觸病人前後洗手，預防微生物散播。

(14)測量並記錄生命徵象。

(15)保持乾淨的環境，確保良好的換氣和表面清潔。

5. 口腔黏膜異常／與淋巴瘤需長期使用類固醇治療有關

(1)評估病人咀嚼和吞嚥的能力。

(2)避免實用柑桔類水果汁、辣的食物、過冷或過熱的食物，有殼的或粗糙的食物。

(3)給予吃清淡的、涼的食物，如：果凍。

(4)教導病人及主要照顧者，給予飯後及睡前作口腔清潔。

(5)依醫囑給予緩解口腔疼痛的溶液（每 2 小時和飯前以 2% Xylocain 漱口）。

(6)依醫囑每 3-4 小時給予輕度的止痛劑。

(7)如有營養狀況少於身體需要時可照會營養師。

(8)給予飲食衛教（高蛋白、高維生素、高熱量、勿太冷太熱太粗糙）。

6. 體液容積太多／與調節機轉失調（心、肝、肺、腎疾病）有關。

(1)每天量體重。

(2)監測攝入量和排出量和尿比重，監測檢驗值。

(3)依病情限制水份、鹽份攝取量，並衛教其重要性。

(4)依醫囑給予利尿劑。

(5)評估周邊水腫。

(6)評估血液動力狀態。

(7)依醫囑給予肌肉收縮劑或血管擴張劑。

(8)評估呼吸音。

(9)評估生命徵象。

主題名稱	淋巴瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	10/13

(10)監測動脈血氣體分析和胸部 X 光。

(11)依醫囑給予氧氣。

(12)改變姿勢，以減輕呼吸困難。

(13)抬高水腫部位。

(14)給予被動與主動的關節運動。

(15)水腫部位，提供適當的皮膚照顧。

7.疼痛不適／與淋巴瘤疾病本身有關

(1)評估病人的疼痛程度及特徵。

(2)評估疼痛加劇的原因。

(3)減少或排除疼痛的因素。

(4)依醫囑使用消炎止痛劑。

(5)給予心理支持，鼓勵家屬在旁陪伴。

(6)安排合適的姿勢。

(7)教導可利用枕頭或毛毯支持疼痛部位。

(8)教導採清淡飲食，勿食用刺激性食物。

(9)教導病人禁止抽煙及喝酒、避免引發疼痛。

(10)維持舒適環境。

(11)予轉移注意力如：音樂、書籍、聊天。

(12)教導放鬆技巧如：深呼吸、背部按摩、冥想等。

(13)在病人選擇控制疼痛方法時予支持與指導。

(14)評值疼痛控制技巧的效果。

(15)評估藥物的效果及副作用。

(九) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

主題名稱	淋巴瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	11/13

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 林浸耀、李珮萱(2021)．照顧一位老年淋巴瘤病人住院接受化學治療之護理經驗．台大護理雜誌，17(1)，40-52。
- (二) 尤達權、黃泰中(2021)．從 2022 年看原發難治性與復發性瀰漫大 B 細胞淋巴瘤的治療理論根據與實際案例．內科學誌，32(6)，431-439。
- (三) 洪詩婷、莊春蜜(2023)．運用 Swanson 理論照護一位初次診斷淋巴瘤病人之護理經驗．腫瘤護理雜誌，3，93-104。

七、附件

(略)

主題名稱	淋巴瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	12/13

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.01.20	1.0	新制定	99 年 01 月 20 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.8.31	2.1	1. 醫護部改護理部 2. 目的內容修辭	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	增修第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	1. 第三項第(一)、(六)目部份內容增修。 2. 新增參考文獻出處於內文中。 3. 第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八目之 1(1) 監測血液檢查值並觀察其變化：刪除 WBC & DC、Hb、Ht、Albumine；新增：CBC/DC 的檢驗報告）。 3. 第六項第一目參考資料修訂	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.06.06	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日照護標準組會議通過； 108 年 06 月 12 日護理長會議通過； 108 年 06 月 18 日督導會議通過公布。

主題名稱	淋巴瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K11	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	13/13

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.18	3.5	第三項第一目、第三目及第六目內容部份修辭。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.6	1. 第三項第一目、第四目、第七目及第八目內容部份修辭及刪除內文參考文獻。 2. 第六項新增參考資料。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過；111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.08.08	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	3.7	修訂第六項參考文獻資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。